

Maladie thrombo-embolique veineuse
Questions d'évaluation 2025
Pr Ag N Ghannouchi – Pr Samia Ernez

QCM

1. Au cours d'une thrombose veineuse:
 - A. Le thrombus est formé essentiellement de leucocytes et de plaquettes
 - B. Le thrombus se développe surtout au niveau des valvules veineuses
 - C. Les lésions endothéliales peuvent être induites par la stase sanguine
 - D. L'état d'hypercoagulabilité sous jacent peut être acquis
 - E. La génération de thrombine est diminuée
2. Les mécanismes conduisant à la survenue de thrombose peuvent être :
 - A. Une hypoxie endothéliale engendrée par l'accumulation de facteurs de coagulation
 - B. Une accumulation des facteurs de coagulation
 - C. Une diminution de la génération de thrombine sous l'effet du facteur VIII activé
 - D. La formation d'un caillot fibrino-cruorique
 - E. Une stase engendrée par une compression tumorale
3. Les inhibiteurs physiologiques de la coagulation sont :
 - A. La protéine S
 - B. La C réactive protéine
 - C. La Thrombine
 - D. L'antithrombine III
 - E. Les phospholipides
4. La recherche d'une thrombophilie constitutionnelle :
 - A. Doit se faire devant toute thrombose du sujet jeune
 - B. Est à réaliser en cas de thrombose non provoquée du sujet jeune
 - C. Est à pratiquer à la phase aiguë de la thrombose
 - D. Est Justifiée en présence d'antécédents familiaux de thrombose
 - E. Comporte le dosage du facteur V
5. La thrombophilie constitutionnelle qui expose le plus au risque de thrombose est :
 - A. Le déficit en antithrombine III
 - B. Le déficit en protéine C
 - C. Le déficit en protéine S
 - D. La mutation 20210 du gène de la prothrombine
 - E. La mutation du facteur V de Leiden
6. Parmi les facteurs favorisant la survenue d'une thrombose veineuse profonde, on note :
 - A. La prise de thalidomide
 - B. L'obésité
 - C. La présence de varices des membres inférieurs
 - D. Le genre masculin
 - E. Le groupe sanguin 0 positif

7. Un état d'hypercoagulabilité explique la survenue de thrombose en cas de :
- A. Maladie de Behçet
 - B. Insuffisance cardiaque
 - C. Insuffisance veineuse chronique
 - D. Maladie de Vaquez
 - E. Syndrome myéloprolifératif
8. Le risque de survenue de thrombose veineuse est :
- A. Plus important chez l'enfant que chez l'adulte
 - B. Favorisé par une diminution du facteur VIII
 - C. Plus élevé pendant la grossesse par rapport à une femme du même âge non enceinte
 - D. Augmenté sous contraception par progestatifs
 - E. Favorisé par la présence d'une mutation du facteur II
9. Une Thrombose veineuse du membre inférieur doit être évoquée devant :
- A. Un œdème unilatéral de la jambe
 - B. Une augmentation de la chaleur locale
 - C. Une abolition du pouls
 - D. Une diminution de la sensibilité superficielle
 - E. Une dilatation veineuse superficielle
10. En présence d'une thrombose poplitée non compliquée, l'examen physique peut retrouver :
- A. Une douleur provoquée sur le trajet vasculaire
 - B. Une abolition du pouls tibial postérieur
 - C. Un cordon superficiel induré et douloureux
 - D. Une peau erythémateuse et luisante
 - E. Une raréfaction des poils
11. Une thrombose veineuse superficielle :
- A. Est favorisée par une insuffisance veineuse des membres inférieurs
 - B. Peut coexister avec une thrombose veineuse profonde
 - C. Se manifeste par un cordon induré et douloureux
 - D. Justifie la réalisation d'enquête étiologique quand elle survient sur un réseau sain
 - E. Nécessite une anticoagulation préventive quand elle est proche de la jonction saphéno-fémorale
12. La localisation aux membres supérieurs d'une thrombose veineuse profonde :
- A. Est moins fréquente que celle aux membres inférieurs
 - B. Peut survenir après une fracture déplacée de la clavicule
 - C. Peut s'étendre à la veine cave supérieure
 - D. Ne se complique pas d'embolie pulmonaire
 - E. Ne justifie pas la réalisation d'une enquête néoplasique

13. Une thrombose veineuse profonde du membre supérieur peut être secondaire à :
- A. Un Cathéter central fémoral
 - B. Un syndrome de Paget-Schroetter
 - C. Un syndrome de Cockett
 - D. Un port de charges lourdes répété
 - E. Une thrombophilie constitutionnelle
14. Une thrombose des veines sus-hépatiques (Syndrome de Budd Chiari):
- A. Peut se manifester par une hépatomégalie douloureuse
 - B. Peut Être évoquée devant une ascite transudative
 - C. Ne se complique pas d'insuffisance hépato-cellulaire
 - D. Peut Révéler une maladie de Behçet
 - E. Peut être en rapport avec un syndrome des anti-phospholipides
15. En présence d'une thrombose veineuse profonde, une maladie de Behçet est à évoquer en présence :
- A. D'antécédant d'uvéite granulomateuse
 - B. D'aphtose buccale
 - C. D'érythème noueux
 - D. D'une intradermoréaction positive
 - E. D'érythème du visage photosensible
16. Les anti-vitamine K :
- A- Ont une activité Activité anti-Xa exclusive
 - B- Inhibent les facteurs de coagulation vitamine K dépendants
 - C- Ont un délai d'action rapide de 3 à 6 heures
 - D- Sont prescrits à dose fixe
 - E- Sont autorisés au troisième trimestre de grossesse
17. Les anticoagulants oraux directs (AOD) :
- A. Inhibent de façon spécifique et directe les facteurs de la coagulation activés
 - B. Sont utilisés à dose fixe par voie orale
 - C. Nécessitent le contrôle par INR de façon régulière pour juger de l'efficacité
 - D. Doivent être adaptés à la clearance de la créatinine
 - E. Ont un délai d'action rapide (2-3 heures)
18. Les Héparines de Bas Poids Moléculaire :
- A. Sont administrées par voie sous cutanée
 - B. Ont un effet anticoagulant immédiat
 - C. Sont contre-indiquée en cas de clairance inférieure à 30 ml/min,
 - D. Peuvent induire une thrombopénie par effet cytotoxique direct des plaquettes
 - E. Doivent être surveillées biologiquement par le dosage de l'activité anti-Xa

Cas Clinique 1 : Patiente âgée de 32 ans, aux antécédents de 3 fausses couches au 1^{er} trimestre, est hospitalisée pour menace d'accouchement prématuré à 32 SA. A J 4 d'hospitalisation, l'examen révèle un œdème et une diminution du ballonnement du mollet droit avec déclenchement d'une douleur à la dorsiflexion. A la biologie, la créatinine = 84 $\mu\text{mol/l}$, Hémoglobine 7.8 g/dl, VGM : 64 fl, TCMH : 21 pg, GB= 9800 éléments/ mm^3 , plaquettes : 564 000 éléments / mm^3 ; Ionogramme : kaliémie 4.2 mmol/l, Natrémie : 138 mmol/l ; Glycémie : 4.6 mmol/l. Vous évoquez une Thrombose veineuse profonde :

- 1- Pour estimer la probabilité selon le score de wells, les éléments dont vous tiendrez compte sont :
 - A. L'hospitalisation >3 jours
 - B. La Douleur du mollet
 - C. L'œdème du membre inférieur
 - D. L'absence de signe de godet
 - E. L'absence de fièvre
- 2- Quelle conduite à tenir à entreprendre ?
 - A. Pratiquer un echo-doppler des membres inférieurs pour confirmer le diagnostic
 - B. Initier un traitement anticoagulant vu le contexte
 - C. Réaliser un dosage des D-Dimères
 - D. Demander un groupage sanguin
 - E. Demander un dosage du taux de prothrombine
- 3- Le diagnostic de thrombose veineuse profonde est confirmé, le traitement fera appel chez cette patiente à :
 - A. Anti-vitamines K après une période de chevauchement avec une HBPM
 - B. Héparine de bas poids moléculaire à dose curative
 - C. Antiagrégants plaquettaires
 - D. Anti inflammatoires non stéroïdiens
 - E. Anticoagulants oraux directs
- 4- L'étiologie de la thrombose Veineuse profonde être un syndrome des antiphospholipides devant :
 - A. Les fausses couches spontanées
 - B. La menace d'accouchement prématuré
 - C. L'anémie
 - D. La microcytose
 - E. La thrombocytose
- 5- Pour confirmer le syndrome des antiphospholipides vous demandez :
 - A. Un dosage du Temps de céphaline activé
 - B. Une recherche d'un anticoagulant circulant de type lupique
 - C. Une recherche d'anticardiolpine d'isotype IgM ou IgG
 - D. Une recherche d'antibéta2glycoprotéine d'isotype Ig A

E. Une recherche d'anticorps antinucléaires

Cas clinique 2 : Patiente âgée de 34 ans, aux antécédents d'arthralgies inflammatoires non explorées depuis quelques mois, est hospitalisée pour exploration d'un syndrome œdémateux. A l'examen physique : T° 37,3 °C - FC= 112batt/mn - FR= 28 c/mn - TA= 135/80 mmHg. Les œdèmes des membre inférieurs étaient mous, gardant le godet et sont plus marqués à gauche où la palpation du mollet est douloureuse. On note par ailleurs une pâleur cutanéomuqueuse avec des cheveux fins et cassants. A la biologie, la VS est à 90 H1, créatinine = 72 umol/l, protéinurie de 24 h : négative. Hémoglobine 7.7 g/dl, VGM : 60 fl, GB= 4600 éléments/mm³, lymphocytes : 800 éléments/mm³, plaquettes : 532000 éléments /mm³; Ionogramme : kaliémie 3.6mmol/l, Natrémie : 138 mmol/l, EPP : Protidémie : 54 g /l , Albumine : 24 g/l , Gammaglobulines : 7.5 g/l

1. L'hypothèse d'une Thrombose veineuse profonde du membre inférieur :

- A. Est à évoquer de principe devant l'œdème asymétrique
- B. Est peu probable devant le caractère mou des œdèmes
- C. Peut expliquer la douleur provoquée par la palpation du mollet
- D. Justifie la réalisation d'un écho-doppler des membre inférieurs
- E. Doit faire pratiquer un dosage des D-dimères

2. Le diagnostic d'une thrombose de la veine fémorale superficielle est confirmé, les mesures thérapeutiques à entreprendre dans l'immédiat sont :

- A. Une immobilisation
- B. Prescription d'un AOD en chevauchement avec les HBPM
- C. Prescription d'une contention mécanique
- D. Initier un traitement héparinique par HBPM à dose curative
- E. Prescrire un anti-agrégant plaquettaire

3. L'enquête étiologique chez cette patiente :

- A- Ne devrait pas être faite vu qu'il s'agisse du premier épisode
- B- Doit comporter une fibroscopie digestive haute
- C- Comportera une recherche d'anticorps anti-nucléaires
- D- Comportera un dosage de l'homocystéine
- E- Comportera un myélogramme devant la lymphopénie

Cas Clinique 3 : Mr M âgé de 72 ans, tabagique à 40 PA, hypertendu, obèse, et dyslipidémique, avec antécédent d'une fracture de la jambe gauche il y a un mois et demi traité par immobilisation plâtrée, se présente pour douleur et lourdeur de la jambe droite. A l'examen physique : Température 36.8 ° C, TA : 90/50 mmHg, FC : 120 batt/min, polypnée à 26 cycles /min. L'auscultation cardiaque et pulmonaire est normale. Il n'y a pas de signes périphériques de choc. L'examen des membres note un œdème non inflammatoire de la jambe droite avec douleur à la dorsiflexion. Les D-Dimères réalisés en villes étaient à 6400 ng/ml

1- Quelle hypothèse diagnostique à évoquer chez ce patient ?

- A. Une dermo-hypodermite du membre inférieur
- B. Une myosite localisée
- C. Un kyste de Baker rompu
- D. Une thrombose veineuse du membre inférieur
- E. Un accès de goutte

2- Quels sont les facteurs pré-disposants de cette maladie que vous relevez chez ce patient?

- A. L'HTA
- B. L'obésité
- C. Le traitement orthopédique
- D. Le tabagisme
- E. La dyslipidémie

3- Une embolie pulmonaire doit être évoquée devant :

- A. La tachycardie
- B. L'hypotension artérielle
- C. L'élévation des D-Dimères
- D. La fièvre associée
- E. La polypnée

4- Le diagnostic étant confirmé, un traitement par antivitamine K a été prescrit après chevauchement par Héparine non fractionnée. Ce traitement :

- A. Justifie la surveillance de l'INR avec une cible située entre 2 et 3
- B. Justifie la surveillance du TCA avec un objectif entre 1.5 et 2 x le témoin
- C. Nécessite une adaptation posologique en fonction de la clearance de la créatinine
- D. Contre-indique l'usage d'AINS
- E. Doit être maintenu à vie

Après quelques mois d'évolution, le patient signale à son rendez-vous une persistance de l'œdème du membre inférieur s'aggravant en fin de journée avec une hyperpigmentation cutanée.

5- Quel diagnostic doit-on suspecter?

- A. Une maladie post phlébitique
- B. Une récurrence de la thrombose
- C. Une dermite de stase
- D. Une dermo-hypodermite bactérienne
- E. Un eczéma